

## ΟΞΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑ

**Γενικά:** Οφείλεται σε αιφνίδια και ταχεία μεγάλη αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης (IOP – Intraocular Pressure) σε επίπεδα 40-70 mmHg (Φ.Τ: 14-22 mmHg), που μπορεί – αν αφεθεί χωρίς άμεση αντιμετώπιση – να οδηγήσει σε μη αντιστρεπτές αλλοιώσεις στον οφθαλμό.

**Κλινική εικόνα:** Εκδηλώνεται συνήθως με τα εξής κλινικά σημεία και συμπτώματα:

- Αιφνίδια εμφάνιση βολβικού άλγους ετερόφθαλμα, συχνά σε σκοτεινό περιβάλλον.
- Η έντονη βολβαλγία μπορεί να επεκταθεί σε όλο το σύστοιχο ήμισυ της κεφαλής.
- Μείωση της οπτικής οξύτητας (*θόλωση όρασης*) και εμφάνιση έγχρωμων κύκλων γύρω από φωτεινές πηγές, που οφείλονται στο αναπτυσσόμενο οίδημα του κερατοειδούς.
- Ερυθρότητα των επιπεφυκότων και σε ορισμένες περιπτώσεις ανισοκορία.
- Αίσθημα κακουχίας και δυσφορίας. Συχνά σύγχυση ή παραλήρημα σε ηλικιωμένους.
- Άτυπο κοιλιακό άλγος, ναυτία, τάση προς έμετο ή έμετος. Η κοιλιάγχη εξηγείται λόγω των κεντρικών συνδέσεων μεταξύ τρίδυμου (V) και πνευμονογαστρικού νεύρου (X).

Ο πάσχων οφθαλμός είναι εξέρυθρος, τα αγγεία του επιπεφυκότα συμπεφορημένα, η κόρη σε μέση μυδρίαση μη αντιδρώσα στο φως, ο πρόσθιος θάλαμος είναι αβαθής και στους δύο οφθαλμούς. Ο πάσχων οφθαλμικός βολβός κατά την ψηλάφηση είναι «σκληρός σαν πέτρα».

**Αίτια:** Εκλυτικός παράγοντας μιας κρίσης μπορεί να είναι το διάβασμα, η παρακολούθηση τηλεόρασης ή κιν/φου, η λήψη βρογχοδιασταλτικών ή εισπνεόμενων αντιχολινεργικών, κ.ά. Παράγοντες κινδύνου: οικογ/κό ιστορικό, ΑΥ, ΣΔ, οφθαλμικό τραύμα, υπερμετρωπία κ.ά.

### Θεραπευτική παρέμβαση

Η ενδοφθάλμια πίεση (IOP) πρέπει να αποκαταστασθεί άμεσα, με τη χρήση:

- ✓ **Υπερωσμωτικών παραγόντων**, χορηγουμένων ενδοφλεβίως (π.χ. *Μαννιτόλη*).
  - ✓ **Αναστολέων της καρβονικής ανυδράσης** (*Ακεταζολαμίδη, Δορζολαμίδη, Βρινζολαμίδη*).
  - ✓ Τοπικών παραγόντων, που μειώνουν την IOP και προκαλούν μύση [π.χ: **β-αναστολείς, α2 αγωνιστές**: Απρακλονιδίνη (*Iopidine*) 1%, Βριμονιδίνη (*Brimontal*) 0,2%].
  - ✓ Τοπικά κορτικοστεροειδή, σε μορφή οφθαλμικών σταγόνων. Αναλυτικά, με βάση αυτά:
1. Χορηγούμε κολλύριο **Πιλοκαρπίνης** ή **ανάλογα των Προσταγλανδινών (PGAs)**, όπως Βιματοπρόστη, Λατανοπρόστη, Τραβαπρόστη, Ταφλουπρόστη:
    - ▶ Πιλοκαρπίνη: 2 drops coll. Pilocollyre 2% ή coll. Isopto-carpine 2% ή
    - ▶ PGAs: 2 drops coll. *Xalatan* 50 mcg/ml ή coll. *Travatan* 40 mcg/ml.Κάθε 5 λεπτά για τα πρώτα 30 λεπτά και στην συνέχεια ανά 6ωρο.
  2. Ταυτόχρονα, χορηγούμε **Ακεταζολαμίδη**, της οποίας η δράση από το στόμα θα αρχίσει μετά από 60-90 λεπτά. Η Ακεταζολαμίδη χορηγείται για βραχύ διάστημα 2-5 ημερών.
    - ♦ tbs. Edemox 200 mg, 1x1 έως 1x5 ή tbs. Admox 250 mg, 1x1 έως 1x4.
  3. Μέχρις ότου αρχίσει η δράση της Ακεταζολαμίδης, που χορηγήσαμε per os, μπορούμε να ενσταλλάξουμε συνδυασμούς φαρμάκων σε μορφή κολλυρίων, όπως παρακάτω:
    - **Δορζολαμίδη + Τιμολόλη**: 1-2 drops coll. *Cosopt* (2+0,5)%,
    - **Βριμονιδίνη + Τιμολόλη**: 1-2 drops coll. *Combigan* (0,2+0,5)%,
    - **Λατανοπρόστη + Τιμολόλη**: 1-2 drops coll. *Latancom / Xalacom* (5+0,5)%,
    - **Βιματοπρόστη + Τιμολόλη**: 1-2 drops coll. *Ganfort* (300+5)mg.
  4. Για να μειώσουμε το άλγος και το stress του ασθενούς, μπορούμε να χορηγήσουμε είτε Παρακεταμόλη (1 amp. Apotel, im) ή/και Διαζεπάμη (amp. Stedon 10 mg, im).

Μετά την ανάταξη της κρίσεως του οξέος γλαυκώματος, αλλά είτε επί επιμονής, είτε και επί επιδείνωσης του επεισοδίου, η διερεύνηση και εκτίμηση της αιτίας του επεισοδίου, καθώς και ο μετέπειτα τρόπος αντιμετώπισης της παθήσεως αποτελεί κύριο μέλημα του οφθαλμιάτρου (π.χ. *Laser περιφερική ιριδεκτομή, γωνιοπλαστική, τραμπεκουλεκτομή, χειρουργική αφαίρεση καταρρακτικού φακού, κ.λπ.*).

